

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE DEPRESIÓN DE CALGARY PARA LA ESQUIZOFRENIA (CDSS / CDS)

Calgary Depression Scale for Schizophrenia (Addington, Addington & Schissel, 1990) · Adaptación Española (Sarró et al., 2004; Bobes et al., 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Depresión de Calgary para la Esquizofrenia (Calgary Depression Scale for Schizophrenia, CDSS)
Sigla / Acrónimo	CDS o CDSS
Autoría original	Donald Addington, Jean Addington & B. Schissel (University of Calgary, Canadá, 1990)
Adaptación en español	Sarró, Dueñas, Ramírez et al. (2004, Schizophr Res); Bobes et al. (2004, CIBERSAM)
Constructo evaluado	Depresión comórbida en pacientes con esquizofrenia, libre de solapamiento con síntomas negativos o extrapiramidales
Población diana	Pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo en fase aguda o estadios deficitarios de mantenimiento
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (heteroadministrada mediante entrevista clínica guiada y observación)
Estructura y formato	9 ítems evaluados en escala Likert de 4 puntos (0 = Ausente a 3 = Grave) con criterios operativos específicos
Condiciones de uso	Dominio público para uso asistencial e investigación académica citando a Addington et al. (1990)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La evaluación de la depresión en personas con esquizofrenia representa uno de los retos clinimétricos más intrincados de la psiquiatría. Las escalas clásicas de depresión (como Hamilton HDRS o Beck BDI-II) están profundamente contaminadas en esta población: ítems como la anhedonia, el enlentecimiento motor, la falta de energía o el retraimiento se solapan con los síntomas negativos primarios de la esquizofrenia (abulia, aplanamiento afectivo) o con los efectos secundarios extrapiramidales de los neurolépticos (acinesia, parkinsonismo farmacológico, sedación).

Para superar este dilema, Donald y Jean Addington concibieron la CDS. Sus 9 ítems fueron rigurosamente seleccionados para captar exclusivamente el **núcleo afectivo y doloroso de la depresión**: el dolor moral subjetivo, la desesperanza, la culpa, el desprecio hacia uno mismo y las ideas suicidas. La escala no mide el embotamiento plano, sino el sufrimiento anímico consciente, siendo el predictor más sensible de suicidio en pacientes psicóticos.

3. LOS 9 ÍTEMES CLÍNICOS DE LA ESCALA DE CALGARY

Ítem	Síntoma Clínico Exploratorio	Rango	Relevancia Diagnóstica Diferencial
1	Estado de ánimo depresivo (tristeza, desánimo)	0 - 3	Dolor moral referido directamente por el paciente
2	Desesperanza (pesimismo ante el futuro)	0 - 3	Pérdida de esperanza vital; predictor de riesgo suicida
3	Autodesprecio (sentirse inferior o defectuoso)	0 - 3	Pérdida profunda de la autoestima personal
4	Ideas de culpa o autorreproche patológico	0 - 3	Culpa no delirante por sucesos cotidianos
5	Despertar precoz matutino (insomnio terminal)	0 - 3	Signo biológico vegetativo de depresión endógena
6	Empeoramiento matutino del estado anímico	0 - 3	Ritmo circadiano típico del trastorno afectivo
7	Ideación suicida y deseos de muerte	0 - 3	Cribado urgente de riesgo autolítico en psicosis
8	Ideas de referencia persecutorias depresivas	0 - 3	Interpretación delirante congruente con la ruina
9	Depresión observada (llanto, facies dolorosa)	0 - 3	Ítem observacional valorado por el clínico

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach $\alpha = 0.83 - 0.89$ en la validación española de Sarró et al. (2004) y $\alpha = 0.86$ en el estudio original canadiense.
Fiabilidad interobservador	Concordancia muy alta entre evaluadores psiquiátricos independientes; coeficiente de correlación intra-clase CCI = $0.89 - 0.94$.
Independencia psicopatológica	Correlación prácticamente nula con la escala de síntomas negativos de la PANSS ($r = 0.08 - 0.14$) y con la escala de extrapiramidalismo de Simpson-Angus ($r = 0.05$), confirmando su especificidad pura.
Sensibilidad y especificidad	Punto de corte ≥ 6 : sensibilidad diagnóstica del 85% y especificidad del 86% para el diagnóstico de episodio depresivo mayor según criterios DSM-IV/5.
Sensibilidad al cambio	Muestra caídas significativas tras la prescripción de antidepresivos coadyuvantes o antipsicóticos atípicos con perfil antidepresivo.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Dinámica de la entrevista	Para los ítems 1 a 8, la escala proporciona preguntas exploratorias abiertas estandarizadas; el ítem 9 se califica en base a la observación de la mímica y conducta durante la sesión.
Gradación operativa	Cada ítem se puntúa de 0 a 3: 0 = Ausente ; 1 = Leve ; 2 = Moderado ; 3 = Grave (guiado por criterios clinimétricos textuales precisos).
Puntuación directa global	Suma aritmética directa de los 9 ítems. Rango teórico posible: 0 a 27 puntos . No existen ítems invertidos.
Marco temporal evaluado	La entrevista explora la sintomatología afectiva experimentada durante las últimas dos semanas .

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación CDS	Percentil Aprox.	Estrato Afectivo	Significación Clínica y Pronóstico
0 - 5 puntos	< Pc 65	Sin Depresión Relevante	Síntomas afectivos aislados o ausentes; no justifica tratamiento antidepresivo.
6 - 8 puntos	Pc 70 - Pc 84	Depresión Leve a Moderada	Presencia de episodio depresivo comórbido; indicación de intervención activa.
9 - 14 puntos	Pc 85 - Pc 94	Depresión Grave	Afectación clínica manifiesta; alto sufrimiento existencial y riesgo suicida.
15 - 27 puntos	$\geq$ Pc 95	Depresión Muy Grave / Extrema	Riesgo letal inminente; requiere monitorización estrecha y hospitalización.

PUNTO DE CORTE CANÓNICO UNIVERSAL (ADDINGTON ET AL.):

- **CDS ≥ 6 puntos:** Punto de corte diagnóstico óptimo para diagnosticar un **Episodio Depresivo Mayor comórbido en la Esquizofrenia** (sensibilidad 85%, especificidad 86%).
- **Alerta Suicida (Ítem 7 ≥ 1):** La presencia de ideas de muerte en la esquizofrenia suele coexistir con insight preservado tras remitir el brote agudo (depresión postpsicótica), período de máxima letalidad.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE DEPRESIÓN EN LA ESQUIZOFRENIA

Paso 1: Aplicación de la CDS: Calcular puntuación total (0 a 27) y revisar Ítem 7 (Suicidio).

Paso 2: Si CDS < 6 con Síntomas Negativos Elevados (PANSS-N): No prescribir antidepresivos; se trata de abulia/apatía primaria defectual; optimizar antipsicótico (cambio a cariprazina o aripiprazol) y rehabilitación psicosocial.

Paso 3: Si CDS < 6 con Parkinsonismo: Reducir dosis de antipsicótico típico o pautar biperideno para descartar acinesia secundaria.

Paso 4: Si CDS ≥ 6 (Episodio Depresivo Comórbido Confirmado):

- Iniciar tratamiento antidepresivo coadyuvante: ISRS de bajo perfil de interacción citocromo (sertralina, escitalopram) o bupropión si predomina la inhibición.
- Reforzar el vínculo psicoterapéutico centrado en la asimilación del diagnóstico psicótico y prevención del aislamiento.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN SALUD MENTAL COMUNITARIA

Identificación: Paciente varón de 24 años con esquizofrenia paranoide, estabilizado clínicamente de su primer brote con paliperidona depot. En los últimos 2 meses la familia refiere que "no sale de la cama y no habla", sospechándose un brote de síntomas negativos o defecto precoz.

Evaluación Diferencial con CDS: Puntuación Total = **11 / 27** (Depresión Grave en Esquizofrenia).

- Ítem 1 (Tristeza) = 2; Ítem 2 (Desesperanza) = 3 (convicción de que su vida está destruida por tener esquizofrenia); Ítem 3 (Autodesprecio) = 2; Ítem 5 (Despertar precoz) = 2; Ítem 7 (Ideación suicida) = 2 ("Pienso a diario que preferiría estar muerto a ser un enfermo mental").

Diagnóstico Integrado: Depresión Postpsicótica de la Esquizofrenia con riesgo autolítico relevante (preservación de insight con duelo traumático de la pérdida de expectativas vitales).

Tratamiento: Se evitó aumentar el antipsicótico; se asoció sertralina 100 mg/día, contrato de seguridad con la familia y psicoterapia individual de aceptación y reconstrucción de metas vitales.

Reevaluación a los 3 meses: La CDS descendió a **3 / 27** (Rango normal), Ítem 7 = 0, integrándose el paciente en un centro de formación ocupacional adaptado.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo de Suicidio:

- **Suicidio en la Esquizofrenia:** El 10% de los pacientes con esquizofrenia fallece por suicidio; la CDS ≥ 6 con buen insight cognitivo es la alarma máxima.
- **Depresión Postpsicótica:** Momento crítico tras el alta hospitalaria al recuperar la conciencia de enfermedad.

Diagnóstico Diferencial Clave:

- **Depresión vs. Síntomas Negativos:** La CDS discrimina el sufrimiento interno vs. el defecto apático sin vivencia dolorosa.
- **Depresión vs. Acinesia por Neurolepticos:** La rigidez motora extrapiramidal responde a antiparkinsonianos, no a antidepresivos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Addington, D., Addington, J., & Schissel, B. (1990). A depression rating scale for schizophrenics. *Schizophrenia Research*, 3(4), 247-251. [https://doi.org/10.1016/0920-9964\(90\)90005-r](https://doi.org/10.1016/0920-9964(90)90005-r)
- Sarró, S., Dueñas, R. M., Ramírez, N., Arranz, B., Martínez, R., Jordà, L., San, L., & Addington, D. (2004). Cross-cultural adaptation and validation of the Spanish version of the Calgary Depression Scale for Schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 68(2-3), 349-356. [https://doi.org/10.1016/S0920-9964\(03\)00155-7](https://doi.org/10.1016/S0920-9964(03)00155-7)
- Addington, D., Addington, J., & Maticka-Tyndale, E. (1993). Assessing depression in schizophrenia: the Calgary Depression Scale. *The British Journal of Psychiatry. Supplement*, 22, 39-44.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.